B.甲状腺危象
C.感染中毒性休克
D.糖尿病酮症酸中毒

13.2019N159 X 关于免疫介导性 T1 糖尿病（1A 型）的临床特点，正确的有
A.多数青少年患者起病隐匿 起病急,症状明显
B.诊断时临床表现变化大
C.多数患者起病初期都需要胰岛素治疗 LADA初期可无需胰岛素治疗
D.多数患者血浆基础胰岛素水平低于正常

14.2020N55 A 男性，55 岁，患有 2 型糖尿病 10 年，用二甲双胍 0.5g 每日三次口服，以及睡前中效胰岛素 20U 皮下注射治疗。血糖监测显示：凌晨两点血糖 2.9mmol/L，空腹血糖 12.0mmol/L。该患者空腹血糖升高的原因是
A.黎明现象 低血糖{糖尿病<3.9 / 正常人<2.8
B.Somogyi 效应→减少中效胰岛素
C.睡前胰岛素剂量不足
D.二甲双胍药物不良反应

早晨

提供基础胰岛素:①白天没有吃东西血糖高,晚上还可以→白天打中效
②白天还可以,晚上没有吃东西血糖高→睡前打中效
③一整天没吃东西血糖都高→打长效

15.2022N159 X 对糖尿病酮症酸中毒患者正确的治疗措施包括
A.早期迅速补液是治疗的关键
B.应用大剂量胰岛素使血糖迅速降至正常水平 小剂量短效胰岛素
C.早期即使血钾正常，尿量＞40ml/h，也应该补钾
D.严重酸中毒时应适量给予补碱治疗 PH≤6.9

16.2023N88-90 A 女性，63 岁。2 型糖尿病 25 年，现用预混胰岛素每日 2 次注射治疗。2 年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近 2 个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞 5-10 个/HP，空腹血糖 9.6mmol/L，HbA1c 8.6%，血 Cr 203μmol/L。B 超检查提示膀胱残余尿量增加。

压力性尿失禁
>5
>7

88.该患者糖尿病微血管并发症的诊断是
A.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
B.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变
C.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病自主神经病变
D.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病周围神经病变

非增生型 NPDR			增生型 PDR（出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤（毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

89.该患者首选的降压药物是
A.利尿剂
B.钙通道阻滞剂
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂

90.为改善血糖控制，最合适的治疗方案是
A.在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍 0.5g，每日 3 次
B.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 次餐时胰岛素 三短一长
C.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 种口服降糖药 胰岛素都搞不定,口服降糖药更搞不定,所以不会加用降糖药
D.单用基础胰岛素 不可能单用,要加量

答案：13-16 BCD B ACD CDB